

## Amenaza de aborto y aborto

---

### 1. Introducción y relevancia clínica

El **sangrado vaginal en el primer trimestre** ocurre en aproximadamente **20–25% de los embarazos**.

De estos, alrededor de **la mitad progresa a aborto espontáneo**.

Por ello, todo sangrado en una embarazada debe considerarse inicialmente como **amenaza de aborto hasta demostrar lo contrario**.

En Chile, el manejo está estandarizado en la **Guía Perinatal MINSAL (2023)** y en la **Norma de Atención Integral de la Mujer**.

Es fundamental distinguir entre:

- **Amenaza de aborto** (embarazo aún viable).
- **Aborto en evolución o incompleto** (expulsión parcial o total del producto).
- **Aborto diferido o retenido** (muerte embrionaria sin expulsión).
- **Aborto séptico** (infección asociada).

El diagnóstico correcto y el manejo oportuno **previenen hemorragias, infecciones y complicaciones psicológicas**.

---

### 2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **aborto espontáneo** se define como la **interrupción del embarazo antes de las 20 semanas o con peso fetal <500 g**.

**Etiología multifactorial:**

- **Causas fetales (50–60%)**
  - Anomalías cromosómicas (trisomías, monosomía X, triploidías).
  - Defectos del desarrollo embrionario.

- **Causas maternas (25%)**
  - Malformaciones uterinas (útero septado, sinequias, miomas).
  - Insuficiencia cervical.
  - Enfermedades sistémicas: DM mal controlada, hipotiroidismo, LES, trombofilias.
  - Infecciones: Listeria, toxoplasma, sífilis, VIH, rubéola.
- **Causas externas (15%)**
  - Tabaco, alcohol, drogas, fármacos teratógenos, radiación.
  - Estrés físico o trauma.

El mecanismo fisiopatológico común es el **desprendimiento del corion frondoso y la placenta**, con pérdida progresiva de soporte hormonal y nutricional fetal.

### 3. Clínica: tipos de aborto

| Tipo                         | Características clínicas                             | Cuello uterino       | Ecografía                          | Evolución                |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Amenaza de aborto            | Sangrado escaso, dolor leve o ausente                | Cerrado              | Embrión vivo, saco íntegro         | Puede continuar embarazo |
| Aborto en curso (inevitable) | Sangrado abundante, cólicos intensos                 | Abierto              | Saco descendiendo o deformado      | Inevitable expulsión     |
| Aborto incompleto            | Expulsión parcial del producto, restos intrauterinos | Abierto o semabierto | Restos visibles en cavidad uterina | Riesgo de hemorragia     |

|                                   |                                         |          |                                     |                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Aborto completo</b>            | Expulsión total, sangrado cede          | Cerrado  | Cavidad vacía                       | No requiere intervención |
| <b>Aborto retenido (diferido)</b> | Cese síntomas de embarazo, sin sangrado | Cerrado  | Embrión sin latido o saco colapsado | Necesita evacuación      |
| <b>Aborto séptico</b>             | Fiebre, dolor, flujo fétido             | Variable | Restos + signos infecciosos         | Urgencia vital           |

□ En EUNACOM, frecuentemente preguntan la **diferencia entre amenaza de aborto (cuello cerrado y embrión vivo) y aborto en curso (cuello abierto y sangrado activo).**

---

## 4. Diagnóstico

a.

### Anamnesis dirigida

- Edad gestacional según FUR.
- Cantidad y características del sangrado (color, coágulos, tejidos).
- Dolor tipo cólico o lumbar.
- Síntomas de embarazo (náuseas, tensión mamaria).
- Antecedentes de abortos previos o enfermedades asociadas.

b.

### Examen físico

- **Signos vitales:** buscar hipotensión, taquicardia, fiebre.
- **Abdomen:** dolor, altura uterina.
- **Tacto vaginal:**

- Cuello cerrado → amenaza.
- Cuello dilatado → aborto en curso o incompleto.
- Flujo fétido → sospecha de aborto séptico.

**C.**

## **Exámenes complementarios**

- **Ecografía transvaginal:**
  - Método diagnóstico de elección.
  - Evalúa saco gestacional, embrión, latido y restos.
  - Confirma embarazo intrauterino y descarta ectópico.

| <b>Hallazgo ecográfico</b>                | <b>Interpretación</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Saco intrauterino con embrión vivo        | Amenaza de aborto     |
| Saco irregular, sin latido, embrión >7 mm | Aborto retenido       |
| Restos ecogénicos intrauterinos           | Aborto incompleto     |
| Cavidad vacía post expulsión              | Aborto completo       |

### ☐ **Criterios diagnósticos ecográficos de aborto retenido (OMS 2021):**

- **CRL >7 mm sin latido, o**
- **Saco gestacional >25 mm sin embrión.**

**d.**

## **Exámenes de laboratorio**

- **hCG sérica cuantitativa:**
    - Debe duplicarse cada 48 h en embarazos normales tempranos.
    - Si no aumenta → embarazo no evolutivo.
  - **Hemograma:** evaluar anemia o leucocitosis.
  - **Grupo sanguíneo y Rh.**
    - Si Rh negativo → administrar **inmunoglobulina anti-D 300 µg**.
  - **PCR y cultivos** si se sospecha aborto séptico.
- 

## 5. Tratamiento (según tipo de aborto y guías MINSAL 2023)

a.

### Amenaza de aborto

- **Manejo expectante y reposo relativo.**
- Control del sangrado y evolución ecográfica.
- **Evitar relaciones sexuales** mientras dure el sangrado.
- **Suplementación con progesterona natural micronizada** (si hay déficit documentado o antecedente de abortos recurrentes).
- Control con **eco seriada** en 7–10 días.
- No hay evidencia de beneficio con reposo absoluto ni antibióticos.

☐ En EUNACOM, la conducta correcta en amenaza de aborto es **observar y controlar**, nunca hospitalizar si no hay compromiso.

---

b.

### Aborto incompleto

- **Tratamiento médico (preferente en MINSAL):**
    - Misoprostol 800 µg vaginal o sublingual, dosis única.
    - Reevaluar con eco en 7 días.
    - Si restos persisten → repetir dosis o evacuar.
  - **Tratamiento quirúrgico (alternativo):**
    - Aspiración manual endouterina (AMEU).
    - Indicada en sangrado abundante o restos grandes.
  - **Antibiótico profiláctico:**
    - Doxiciclina 100 mg cada 12 h por 7 días.
  - **Analgesia y apoyo psicológico.**
- 

**c.**

### **Aborto completo**

- Confirmar con ecografía.
  - No requiere tratamiento activo.
  - Indicar hierro, reposo breve y control en 1–2 semanas.
- 

**d.**

### **Aborto retenido (diferido)**

- **Manejo médico:**
  - Misoprostol 800 µg vaginal cada 6 h, hasta 2 dosis.
  - Reevaluar con eco; si restos persisten → AMEU.
- **Manejo quirúrgico:**

- AMEU o legrado si misoprostol falla o sangrado excesivo.
  - **Antibióticos profilácticos.**
- 

e.

### **Aborto séptico**

- **Urgencia obstétrica.**
- Hospitalización inmediata.
- **Antibióticos de amplio espectro:**
  - Clindamicina 900 mg IV c/8h + Gentamicina 5 mg/kg/día.
  - Añadir Ampicilina o Metronidazol si se sospecha anaerobios.
- **Evacuación uterina urgente** tras estabilizar paciente.
- **Soporte hemodinámico y vigilancia intensiva.**

Mortalidad materna en aborto séptico puede llegar al 10–15% sin tratamiento oportuno.

---

## **6. Consideraciones especiales**

- En pacientes **Rh negativo no sensibilizadas**, aplicar **inmunoglobulina anti-D 300 µg** post evento.
  - Evaluar **causas subyacentes** si abortos recurrentes ( $\geq 3$  consecutivos):
    - Cariotipo parental.
    - Estudio uterino (eco 3D, histerografía).
    - Trombofilias o autoinmunidad.
    - Deficiencia de progesterona.
-

## 7. Complicaciones

| Tipo          | Ejemplos                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hemorrágicas  | Shock hipovolémico, anemia severa                                  |
| Infecciosas   | Endometritis, sepsis, síndrome de Sheehan                          |
| Reproductivas | Sinequias uterinas (síndrome de Asherman), infertilidad secundaria |
| Psicológicas  | Trastornos depresivos o duelo patológico                           |

---

## 8. Aspectos legales y éticos (Chile)

La **Ley 21.030 (2017)** permite la interrupción del embarazo en tres causales:

1. **Riesgo vital materno.**
2. **Inviabilidad fetal de carácter letal.**
3. **Embarazo producto de violación.**

Los abortos espontáneos o incompletos **no están penalizados**, pero deben documentarse adecuadamente.

El manejo debe incluir **acompañamiento psicológico** y registro clínico completo (diagnóstico, tratamiento y evolución).

---

## 9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



**Perlas**

1. **Amenaza de aborto:** sangrado leve, cuello cerrado, embrión vivo.
2. **Aborto en curso:** cuello abierto, sangrado activo, inevitable.
3. **Aborto incompleto:** restos intrauterinos; manejo con **misoprostol o AMEU**.
4. **Aborto retenido:** embrión sin latido; confirmar con **eco**.
5. **Rh negativo:** administrar **anti-D 300 µg**.
6. **Aborto séptico:** fiebre, dolor y flujo fétido → **antibióticos + evacuación**.



### Errores comunes

- Indicar reposo absoluto prolongado en amenaza de aborto.
- No usar ecografía para confirmar tipo de aborto.
- Omitir profilaxis anti-D.
- Confundir aborto incompleto con ectópico.
- Retrasar evacuación en aborto séptico.

---

## 10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El aborto espontáneo es la **pérdida del embarazo antes de 20 semanas o <500 g**.
2. La **amenaza de aborto** cursa con **sangrado leve y cuello cerrado**.
3. El diagnóstico es **ecográfico**, y el manejo depende del tipo (expectante, médico o quirúrgico).
4. **Misoprostol 800 µg** es el tratamiento médico de elección (según MINSAL).
5. Toda mujer **Rh negativo** debe recibir **anti-D post evento**.
6. El **aborto séptico** requiere **antibióticos y evacuación urgente**.

7. La **ecografía transvaginal** es la herramienta clave para diferenciar amenaza, aborto retenido y completo.